

Urticaria y Angioedema

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
AEP 2013

Lesión en piel consecuente de la liberación por parte de las células (mastocitos y basófilos) de mediadores preformados, siendo la histamina el más importante y sería el responsable de la expresión cutánea.

Angioedema: puede presentarse aislado o asociado a urticaria, aproximadamente en el 50% de los casos suelen coexistir y en el 10% de los casos angioedema aislado. La urticaria puede afectar a toda la superficie cutánea, el angioedema afecta al tejido subcutáneo siendo la región periorbitaria, los labios, lengua, genitales y zonas distales de extremidades, las más afectadas; a diferencia de la urticaria no suele ser pruriginoso.

Etiología

Virus y bacterias: la infección es la causa más frecuente de urticaria en la infancia. Se diagnostica habitualmente por la clínica y la exclusión de otros desencadenantes. La patogénesis no está clara y se manejan hipótesis como son la activación inmunológica, con formación de inmunocomplejos y/o activación del complemento. En algunos cuadros refractarios al tratamiento con antihistamínicos y con respuesta a azitromicina, se ha comprobado infección por *Mycoplasma*.

Alimentos:

Un tercio de los episodios urticariales se deben a ingestión de alimentos. Puede producirse también urticaria mediada por IgE por contacto con alimentos.

Inhalantes

Con frecuencia en relación a epitelios de animales, aunque generalmente van acompañando a sintomatología respiratoria.

Fármacos

Sobre todo los antibióticos betalactámicos se pueden asociar a urticaria en un bajo porcentaje de las (5-10%), atribuyéndose el resto a urticaria en relación a infecciones.

Insectos

Es poco habitual, existen algunos casos de sintomatología IgE mediada por picadura de mosquito, pero en la mayor parte de los casos se trata de reacción local a la inyección de la sustancia irritante (prurigo escrófulo o urticaria papular por insectos).

Látex

Puede ser causa de urticaria, angioedema y el resto de las manifestaciones típicas de las reacciones mediadas por IgE, incluida la anafilaxia.

Parásitos: las infecciones parasitarias, especialmente con helmintos, equinococo, toxocara y strongiloides, pueden causar urticarias agudas asociadas con eosinofilia marcada.

Angioedema hereditario familiar

Se trata de una enfermedad autosómica dominante caracterizada clínicamente por ataques recurrentes de angioedema, generalmente sin urticaria.

Las lesiones no producen prurito y el edema es duro, frío, blanco y a tensión. Puede provocar dolor abdominal importante y dificultad respiratoria grave por edema de glotis. Los factores desencadenantes son estrés emocional, traumatismos graves, infecciones e intervenciones quirúrgicas.

El trastorno transmitido es una deficiencia o disfunción del inhibidor C1.

Alteraciones del metabolismo del ácido araquidónico

En la infancia, la intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos (AINE) provoca fundamentalmente clínica de edema palpebral. El mecanismo está relacionado con la inhibición de la ciclooxigenasa, que interfiere la producción de prostaglandinas a través del ácido araquidónico.

La sintomatología comienza entre 30 y 90 minutos tras la administración del fármaco y es dosis dependiente.

Agentes degranuladores de los mastocitos

Algunos fármacos inducen liberación de mediadores actuando directamente sobre los mastocitos o basófilos. Entre ellos, se encuentran algunos opiáceos, antibióticos polianiónicos y curarínicos. Los medios de contraste radiológicos actúan a través de violentos cambios en la osmolaridad del plasma causando degranulación por mecanismos irritativos.

Urticarias físicas

Los habones se producen por estímulos físicos: mecánicos (roce, presión), frío, calor, aumento de la temperatura corporal, ejercicio, irradiación solar, vibración, contacto con el agua.

Urticaria papulosa (prurigo estrófulo)

Se presenta con lesiones eritematopapulares agrupadas, pruriginosas, de 4-5 mm de diámetro, con halo eritematoso, que aparecen generalmente en áreas descubiertas.

Afectan especialmente a cara, cuello, extremidades inferiores (zona de calcetín), cintura y antebrazos.

Son consecuencia de picaduras de insectos, mosquitos, pulgas, moscas, piojos, etc. Son lesiones locales.

Suelen evolucionar en dos fases, una inmediata y otra en los días siguientes, que parecen exacerbarse por nuevas picaduras. Son frecuentes las sobreinfecciones bacterianas por rascado.

Urticaria de contacto no IgE mediada (tóxicas)

El cuadro aparece como lesiones en áreas expuestas tras el contacto con plantas o animales que segregan sustancias irritantes como ortigas u orugas, sobre todo la procesionaria del pino, que puede causar síntomas a distancia y en ocasiones urticarias mediadas por IgE.

Urticaria crónica

Se consideran el 30% de las urticarias físicas.

Diagnóstico

El diagnóstico mismo de la enfermedad es evidente por la simple exploración (lesiones habonosas, eritematosas y pruriginosas).

En las urticarias mediadas por IgE, el nexo causal es fácil de establecer.

Edad:

- Primer año de vida, los alimentos y las infecciones son los desencadenantes más frecuentes.
- Según introducción de alimentos
 - Leche: primer semestre
 - Huevo y pescado a los 12 meses
 - Legumbres a partir del segundo año
- Preescolar y escolar siguen siendo frecuentes las ligadas a infecciones y aparecen las relacionadas con parasitosis, el prurigo estrófulo y la intolerancia a AINE.

- Otras patologías como el edema angioneurótico familiar y las urticarias idiopáticas aparecen en edades superiores.

Pruebas complementarias

Cuando existe historia sugestiva de mecanismo IgE, debe confirmarse mediante la realización de estudio inmunoalérgico, incluyendo pruebas cutáneas y estudio *in vitro*.

Si hay dudas en el caso de alimentos o medicamentos, se debe realizar provocación controlada.

Fuera de este supuesto, la utilidad diagnóstica de las pruebas cutáneas “de rutina” es muy baja y son frecuentes los falsos positivos, por dermatografismo o por liberación inespecífica de histamina sobre una piel irritada. Pueden obtenerse asimismo pruebas positivas, pero que corresponden a alérgenos no responsables de esta clínica.

Durante años se ha recomendado la utilización de dietas muy restrictivas, con introducción paulatina de alimentos, como método diagnóstico y de tratamiento. Su utilidad es prácticamente nula y su cumplimiento difícil y molesto.

En urticarias recurrentes puede resultar informativo un diario dietético, para buscar la presencia de alimentos que se asocien con los brotes.

Tratamiento

1. Evitación de la causa y, si no es posible, se realizará tratamiento preventivo ante situaciones de riesgo con premedicación con antihistamínicos.

En algunas urticarias existen preventivos específicos, como filtros solares, lociones antimosquitos, intentos de desensibilización a frío por exposición progresiva o provocación de periodos refractarios en la urticaria colinérgica, mediante baños calientes.

	Tratamiento sintomático	Tratamiento etiológico
Urticaria aguda	Según gravedad: • Antihistamínicos orales • Corticoides orales Puede ser necesaria adrenalina IM en el momento agudo	Según desencadenantes
Urticaria crónica idiopática	Tratamiento sintomático	Secuencia
	Antihistamínicos: • Sedantes en niños pequeños • No sedantes en escolares y adolescentes	1. Tratamiento inicial
	Antihistamínicos no sedantes aumentando la dosis incluso por cuatro	2. Si persisten síntomas más de dos semanas
	• Corticoides orales 3-7 días • Antagonistas de los leucotrienos y/o cambio de antihistamínico	3. Si con el tratamiento anterior persisten síntomas más de 1-4 semanas o exacerbación
	• Corticoides orales 3-7 días • Ciclosporina A • Anti-H2 • Dapsona	4. Si con el tratamiento anterior persisten síntomas más de 1-4 semanas o exacerbación
	Omalizumab	5. Solo en casos de urticaria- angioedema grave y refractario a tratamiento

- Cuadros agudos: antihistamínicos de primera generación (ejemplo: difenhidramina, hidroxicina): mayor efecto sobre el prurito y efecto sedativo.
- Urticarias prolongadas: antihistamínicos de segunda generación (ejemplo: cetericina, loratadina) por su menor efecto sedante.
- En ocasiones: 1º generación diurno, 2º generación antes de dormir.
- Mala respuesta a antihistamínicos: Meprednisona 1-2 mg/kg

Vademécum (Garrahan)

• Hidroxicina Clorhidrato

Nombre Comercial Ataraxone; Hyderax; Hidroxicina ICN Arg.

Acción terapéutica: antihistamínico. Antiemético. Sedante.

Dosis

Niños: 2 mg/kg/día cada 6-8 hs

Adultos: 25 mg/dosis cada 6-8 hs.

Dosis máxima: 6 meses a 6 años: 50 mg/día, 7 a 12 años: 50-100 mg/día, 12 a 18 años: 100 mg/día. En cirrosis biliar primaria cambiar el intervalo de dosis a una vez por día.

Vías de Aplicación: V.O.

Efectos Adversos Irritabilidad, ataxia, vertigo, tinnitus, fatiga, anorexia, diarrea, alopecia, hipotensión, retención urinaria.

Forma de Presentación: Comprimidos: 10-25 mg Jarabe: 2 mg/ml

Observación Su considerable actividad depresora central puede contribuir a su acción anti pruriginosa prominente. Puede potenciar otros depresores del S.N.C..

• Difenhidramina

Nombre Comercial Benadryl; Drepatil; Histaler

Antihistaminico. Coadyuvante antiemetico. Sedante.

Dosis

Lactantes: 1 mg/kg/día

Niños: 5 mg/kg/día cada 6-8 hs

Dosis máxima: 300 mg/día

Adultos: 25-50 mg/dosis cada 4 hs, dosis maxima: 400 mg/dia.

Vías de Aplicacion V.O. E.V. I.M.

Efectos Adversos: Actividad antimuscarinica significativa, sedacion. Mareos, tinnitus, fatiga, diplopia, lasitud, incoordinacion, hipotension, nauseas, vomitos, retencion urinaria. S

obredosis: psicosis, fiebre, alucinaciones, convulsiones.

Forma de Presentacion:

Capsulas: 50 mg

Jarabe: 2,5 mg/ml

Ampollas o F.A.: 10 mg/ml

Observación

< de 6 meses pueden presentar hiperexcitabilidad paradojal. No usar en neonatos.

V.O.: administrar con alimentos. Contraindicado en crisis asmaticas.

• Loratadina

(Clarityne; Alerpriv; Bedix; Biloina; Lertamine; Nularef)

Dosis:

Niños mayores de 2 años y < de 30 kg: 5 mg/dia; > de 30 kg y

Adultos: 10 mg/dia, una vez al día. Ver tabla de ajuste de dosis en I.R.

V.O.

EA: Sedacion, boca seca, cefalea, taquicardia, fatiga, nauseas, leve efecto anticolinergico, trombocitopenia, cambios de conducta, rash.

Presentación: 10 mg Jarabe: 1 mg/ml

Administrar con el estómago vacío o antes de las comidas.

En insuficiencia hepatica dar dosis en dias alternos. Contraindicado en glaucoma.

Precaucion en pacientes asmaticos. Aumenta su concentracion plasmatICA con ketoconazol, eritromicina, fluconazol, fluoxetina.